Complexo Habitacional Temporário Restaurador e Centro de Apoio à Saúde Mental Pós-Desastre

1. Delimitação do tema e do fenômeno:

Este projeto insere-se nos campos da Arquitetura e da Psicologia Ambiental, fundamentando-se na influência direta do ambiente construído na saúde mental e na regulação emocional em cenários pós-desastre, cuja ocorrência tem sido intensificada pelas mudanças climáticas. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), os eventos climáticos e meteorológicos extremos são vetores crescentes de deslocamento forçado e vulnerabilidade populacional. Entre 1970 e 2019, os desastres naturais corresponderam a 50% do total de catástrofes globais, somando mais de 11 mil ocorrências climáticas registradas; apenas as enchentes vitimaram 58,7 mil pessoas (GRANDI, 2025).

No Brasil, entre 2018 e 2022, registraram-se 39 eventos de desastres que afetaram 11.900.934 pessoas, destacando-se o Estado de Santa Catarina como o mais atingido do país, com 2.432 eventos e 5.972.014 afetados (GRANDI, 2025). O impacto psíquico sobre as populações deslocadas é severo: a prevalência de transtornos mentais em populações afetadas por desastres é de duas a três vezes maior do que na população geral (ZHANG et al., 2026), chegando a ultrapassar 50% das vítimas em países em desenvolvimento com sofrimento psicológico grave ou transtornos psiquiátricos (GRANDI, 2025).

A revisão sistemática de 22 estudos globais conduzida por Zhang et al. (2026) aponta que o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é o desfecho mais frequente em pós-desastres (36,4% dos estudos), seguido por estresse e ansiedade (18,2%). Ademais, a precariedade do abrigamento temporário duplica o risco de desenvolvimento de TEPT em relação à permanência no lar original (ZHANG et al., 2026). Em pesquisas de campo com desabrigados, 93,3% dos entrevistados exigem a divisão espacial interna por divisórias para garantir privacidade e 80% priorizam o afastamento entre módulos habitacionais para evitar conflitos e restaurar a dignidade (GRANDI, 2025).

Dados da OMS apontam que 86% da população brasileira apresenta algum tipo de transtorno mental, tornando-se urgente superar a inadequação dos abrigos emergenciais convencionais (VASCONCELOS, 2025). A integração da arquitetura terapêutica e do design biofílico oferece fundamentação científica a essa resposta

projetual: pesquisas demonstram uma correlação estatística significativamente alta (r = 0,768) entre diretrizes de arquitetura terapêutica e a percepção espacial positiva e recuperação emocional dos usuários (LÓPEZ-RODRÍGUEZ et al., 2025).

A lacuna investigada reside na inadequação dos modelos convencionais de abrigos e habitações temporárias, que se limitam ao atendimento emergencial básico e negligenciam aspectos essenciais como privacidade, conforto bioclimático e áreas de convivência em contato com a natureza (GRANDI, 2025). A ausência desses atributos espaciais impede a criação do sentimento de pertencimento, ativando continuamente o sistema nervoso simpático, o que exacerba a vulnerabilidade psíquica, compromete a regulação emocional e viola a dignidade das populações deslocadas (DELGADO, 2022; GRANDI, 2025; ZHANG et al., 2026).

Assim, o diferencial deste projeto está em investigar como integrar diretrizes da arquitetura terapêutica e da teoria dos ambientes restauradores na concepção de um Complexo de Saúde Mental de uso permanente com estruturas reservadas para habitações temporárias ativáveis em pós-desastres, promovendo a recuperação psicológica, a autonomia e a reconstrução digna da vida das vítimas.

2. Justificativa:

A crescente frequência de eventos climáticos extremos e desastres urbanos expõe populações vulneráveis a severos traumas psíquicos, decorrentes da perda repentina do lar e da desestruturação socioespacial. A relevância social e urbana do tema fundamenta-se no fato de que o ambiente construído atua como modificador de efeito na saúde mental pós-desastre. Reestruturar o habitat de maneira digna, humanizada e restauradora é, portanto, indispensável para a recomposição do tecido urbano, para o fortalecimento da resiliência comunitária e para o restabelecimento da estabilidade emocional das populações deslocadas.

Quanto à contribuição técnico-científica, os modelos convencionais de abrigamento de emergência limitam-se à sobrevivência biológica básica, evidenciando uma lacuna projetual ao produzirem estruturas padronizadas, impessoais e destituídas de privacidade, conforto bioclimático e suporte emocional. O diferencial deste trabalho reside em enfrentar essa carência não resolvida ao aplicar diretrizes da arquitetura terapêutica no desenho de um Complexo Habitacional Temporário, articulado a um Centro de Apoio à Saúde Mental

permanente e a espaços de convivência comunitária. A proposta acrescenta conhecimento ao campo ao sintetizar princípios do design biofílico e da psicologia ambiental em habitações emergenciais, superando a mera lógica assistencialista por meio de um modelo espacial voltado à regeneração psíquica, autonomia e dignidade das vítimas.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral:

Projetar um Complexo Habitacional Temporário Restaurador e Centro de Apoio à Saúde Mental Pós-Desastre.

3.2 Objetivos específicos:

- Incorporar diretrizes da arquitetura terapêutica em estratégias espacial-projetuais para os ambientes de atendimento e acolhimento psíquico;
- Desenvolver habitações temporárias que garantem privacidade e conforto bioclimático em situações de emergência;
- Projetar áreas de convivência comunitárias;

4. Recorte da revisão de literatura

A literatura sobre a relação entre espaço, saúde mental e abrigamento organiza-se em quatro abordagens centrais. A primeira analisa o ambiente construído como preditor direto e modificador de danos psíquicos em eventos extremos (ZHANG et al., 2026). A segunda, no âmbito da psicologia ambiental e do habitar temporário, examina os atributos restauradores e a recriação do "senso de lar" para aliviar o estresse em populações deslocadas (DELGADO, 2022; GRANDI, 2025). A terceira, voltada à arquitetura terapêutica e à humanização clínica, valida estatística e qualitativamente a influência de parâmetros físicos — luz natural, biofilia e ergonomia — na percepção espacial e no cuidado psicossocial (LÓPEZ-RODRÍGUEZ et al., 2025; VASCONCELOS, 2025). Por fim, a abordagem utilizada para projetar espaços comunitários tem como diretriz principal a escala humana, a fim de promover o bem-estar e o pertencimento social (GEHL, 2013).

Observa-se convergência no entendimento de que o ambiente edificado atua ativamente na regulação emocional e na resiliência. Contudo, também se apresentam lacunas e tensões: os modelos habitacionais de emergência focam na

sobrevivência biológica imediata, negligenciando o conforto bioclimático e o apoio psiquiátrico (DELGADO, 2022; GRANDI, 2025), enquanto os estudos em arquitetura terapêutica concentram-se em equipamentos clínicos estáticos e permanentes, desconsiderando o deslocamento forçado (LÓPEZ-RODRÍGUEZ et al., 2025; VASCONCELOS, 2025). Ademais, a dimensão comunitária e pedonal proposta por Gehl (2013) é raramente articulada com a necessidade de intimidade e proteção psíquica em cenários pós-catástrofe.

Este projeto situa-se na interseção dessas vertentes ao propor um Complexo Habitacional Temporário integrado a um Centro de Apoio à Saúde Mental Pós-Desastre. A resposta projetual enfrenta as lacunas identificadas ao articular a escala humana e comunitária (GEHL, 2013), a restauração do habitar provisório (DELGADO, 2022; GRANDI, 2025) e as diretrizes clínicas humanizadas (LÓPEZ-RODRÍGUEZ et al., 2025; VASCONCELOS, 2025) em um modelo espacial contínuo.

5. Conceitos estruturantes da proposta

A fundamentação conceitual desta proposta articula quatro conceitos estruturantes interligados, para compreender o fenômeno do trauma psíquico pós-desastre e orientar uma resposta projetual integrada.

O primeiro conceito é o do Ambiente Construído como Preditor e Modificador da Saúde Mental Pós-Desastre (Zhang et al., 2026). Ele estabelece que a configuração física do espaço não é um pano de fundo passivo, mas uma variável ativa capaz de agravar o estresse pós-traumático ou atuar como fator de proteção e resiliência. Em cenários de catástrofe climática, a desestruturação do entorno físico desorganiza os pontos de referência subjetivos da população deslocada, exigindo que a intervenção arquitetônica atue intencionalmente na mitigação dos danos psicológicos.

O segundo conceito são os Atributos Restauradores do Habitar Transitório e a Recriação do Senso de Lar (Delgado, 2022; Grandi, 2025). Esse conceito defende que o abrigamento de emergência deve ultrapassar a lógica assistencialista da mera sobrevivência biológica. A restauração psíquica do indivíduo deslocado depende de qualidades ambientais específicas: privacidade, conforto bioclimático, flexibilidade espacial e identidade cultural. A presença desses atributos estimula o sistema

nervoso parassimpático, reduzindo os níveis de cortisol e devolvendo às vítimas o sentimento de segurança, autonomia e pertencimento.

O terceiro conceito refere-se aos Atributos da Arquitetura Terapêutica e Humanização Espacial (López-Rodríguez et al., 2025; Vasconcelos, 2025). Voltado tanto às instalações de suporte psicossocial quanto aos espaços habitacionais, este conceito sustenta que parâmetros físicos mensuráveis — como orientação solar, iluminação natural filtrada, ventilação cruzada, biofilia e ergonomia — influenciam diretamente a regulação emocional dos usuários. A literatura comprova forte correlação estatística (r = 0,768) entre o desenho humanizado dos ambientes e a percepção espacial positiva, demonstrando que a espacialidade pode reduzir a ansiedade e favorecer a recuperação psíquica.

O quarto conceito é o da Escala Humana e Vitalidade Comunitária (Gehl, 2013). Aplicado ao desenho urbano e ao agenciamento dos espaços de convivência, Gehl defende que o projeto deve ser dimensionado a partir dos sentidos, da caminhabilidade e do ritmo de locomoção dos pedestres. Em contextos de vulnerabilidade pós-desastre, a criação de caminhos protegidos, praças de transição e pontos de encontro na escala humana fortalece os laços comunitários, combate o isolamento social e restaura o sentimento de vida pública coletiva.

A articulação desses quatro conceitos permite compreender o fenômeno: a mitigação do estresse urbano (Zhang et al., 2026) viabiliza-se pela dignificação do abrigo temporário (Delgado, 2022; Grandi, 2025), cuja eficácia clínica é potencializada pelas diretrizes da arquitetura terapêutica (López-Rodríguez et al., 2025; Vasconcelos, 2025) e integrada ao tecido social mediante a escala humana (Gehl, 2013).

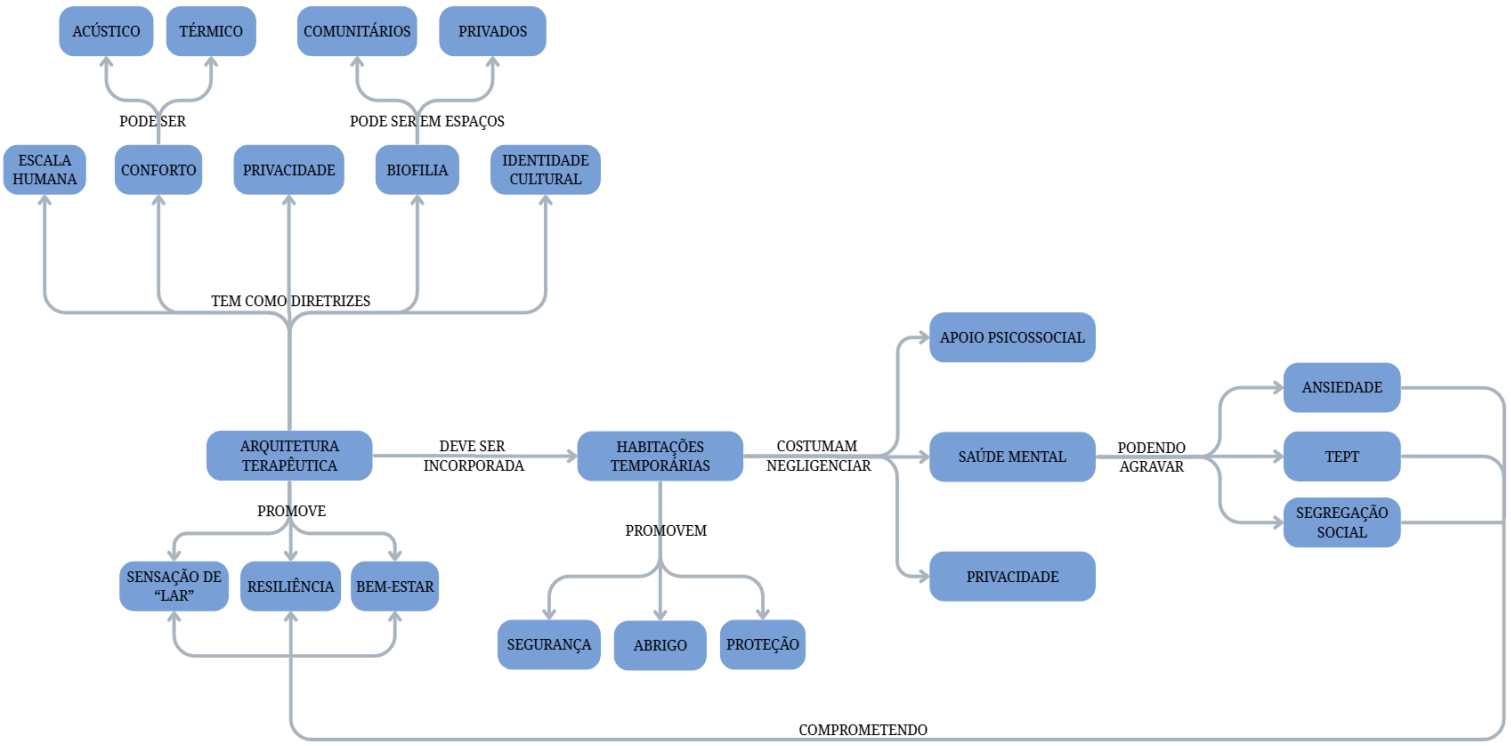
6. Síntese interpretativa

Os conceitos estruturantes orientam a investigação ao deslocar a resposta emergencial da mera sobrevivência biológica para a centralidade do bem-estar psíquico e da escala humana. Ao reconhecer o ambiente construído como preditor e modificador dos impactos psicológicos pós-desastre (ZHANG et al., 2026), a pesquisa enfrenta a desumanização dos abrigos convencionais. Os atributos restauradores do habitar provisório (DELGADO, 2022; GRANDI, 2025) e as diretrizes de arquitetura terapêutica (LÓPEZ-RODRÍGUEZ et al., 2025; VASCONCELOS, 2025) fornecem os parâmetros físicos — privacidade, conforto

bioclimático, e biofilia — necessários para fundamentar o acolhimento temporário e o suporte clínico contínuo. Articulados à escala humana de Gehl (2013), esses princípios garantem o sentimento de pertencimento e a recomposição dos laços comunitários.

Dessa forma, os conceitos dialogam com o problema ao fundamentarem uma resposta projetual integrada que transforma o abrigo emergencial em um instrumento ativo de regeneração psíquica e reconstrução digna da vida.

7. Diagrama conceitual



8. Referências:

GRANDI, Andreia. Atributos Ambientais de Abrigos e Habitações Temporárias: Contribuições para o Bem-Estar em Cenários de Desastre. Orientadora: Lisiane Ilha Librelotto. Coorientadora: Luana Toralles Carbonari. 2025. 181 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025.

LÓPEZ-RODRÍGUEZ, Angie Susana; BUSTAMANTE-GUADO, Guillermo Alberto; CRUZADO-PALACIOS, María Delia. Arquitetura terapêutica e percepção espacial nos ambientes de um Centro de Saúde Mental. **In**: LACCEI INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE FOR ENGINEERING, EDUCATION, AND TECHNOLOGY, 23., 2025, Cidade do México. **Anais [...]**. Cidade do México: LACCEI, 2025.

ZHANG, Yue; LI, Dongying; NEWMAN, Galen; LIU, Yining; BESSE, Emily. Características do ambiente construído preditores ou modificadores de efeito nos resultados de saúde mental pós-desastre: Uma revisão sistemática. **Social Science & Medicine**, v. 360, 2025/2026 .

DELGADO, Marta. Home is restoration: Towards a health-based model of the importance of home for survivors of natural disasters. **Social Sciences & Humanities Open**, v. 6, n. 1, art. 100351, p. 1-8, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100351.

IPCC - INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Edited by Core Writing Team, Hoesung Lee and José Romero. Geneva: IPCC, 2023. 115 p. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.df. Acesso em: 13 out. 2026.

VASCONCELOS, Lorena Alves. Reforma Psiquiátrica e Arquitetura Humanizada: Caminhos para a Superação do Modelo Manicomial. Orientadora: Helena Gouvêa Rocha Alves. Coorientadora: Sarah Gabriela Oliveira. 2025. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), Barbacena, 2025.

GEHL, Jan. Cidade para pessoas. Tradução: Anita Di Marco. 2\. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. 276 p.